# EPICRISIS MÉDICA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| HOSPITAL | : | HOSPITAL DE SAN CARLOS | Nº EGRESO | : | 87599 |
| SERVICIO | : | MEL HOMBRES HSC | | | |
| FECHA | : | 2024-06-30 12:43:00 | | | |

## DATOS DEL PACIENTE:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | : SOFIA CATALINA PRIETO SAN MARTIN | | | RUN | : 22.620.440-7 |
| F.Nac | : 27-06-2024 | Edad | : 0 AÑO | Género | : Femenino |
| Dirección | : | | | Comuna | : SAN NICOLAS |
| Previsión | : SIN INFORMACION | Teléfono | : 0 | | |
| Fecha Ingreso | : 2024-06-27 | Fecha Egreso | : 2024-06-30 12:43:00 | Causal | : MEDICA |
| Condición | : VIVO | Destino | : HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA | Derivación | : |

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. J18.9-NEUMONIA, NO ESPECIFICADA

## DIAGNOSTICO(S) EGRESO

Neumonía lobar superior izquierdo

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. J18-NEUMONIA, ORGANISMO NO ESPECIFICADO (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

## COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente refiere inicio de sintomatología hace 1 semana presentando accesos de tos intermitente leve a moderada asociado a rinorrea, cefalea, mialgia y aumento de temperatura corporal >39°.
En primera instancia, acude a servicio de urgencias el 23/06 donde se diagnostica amigdalitis ¿streptococcica? por lo que se indica PNC benzatínica 2.4 mill unidades IM en dosis única.
Se deriva a domicilio con terapia complementaria analgésica antiinflamatoria.
Reacude a este servicio por persistencia de cuadro febril.
Se toman exámenes de laboratorio donde destaca elevación de parámetros inflamatorios.
Estudio de imagen se decide TC TX donde se evidencia proceso de consolidación inflamatorio-infeccioso lobar superio izquierdo asociado a derrame localizado.
Paciente de domicilio rural.

En vista de condiciones se decide hospitalización hasta caracterización y terapia acorde.

Ex físico
Piel: cambios y signos propios de la edad. Buen llenado capilar.
ORL: Mucosa indemne, pilares conservados, sin lesiones amigdalinas, sin eritema o signos de inflamación.
Cuello: no se palpan adenopatías
CP: Torax asimétrico, normoexpansible, RSRPS, disminuidos tercio medio campo izquierdo, RSCSRSRS SSNG
Abd: RHA+, sin megalias, no impresiona doloroso a la palpación.

Durante estancia en servicio de medicina en buenas condiciones generales, sin nuevos episodios febriles, sin compromiso ventilatorio o requerimiento de oxígeno desde ingreso.
Se toma TC de TX que reporta proceso inflamatorio infeccioso sugerente de neumonía en segumento apicoposterior, linguar superior y lingular inferior en lobulo superior izquierdo, asociado a leve derrame pleural.
Se toman hemocultivos negativos a la fecha. Sin posibilidad de tomar CSB por escasas secreciones.
Parámetros inflamatorios en descenso con buena respuesta paraclínica, sin compromiso de alguna otra esfera.
Recibiendo ceftriaxona 2gr ev día, actualmente en 4/7 además de Azitromicina (4/5)
En vista de condiciones clínicas, red de apoyo y domicilio se decide continuidad de atención via HODOM

## INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo relativo
2. Regimen común
3. Ceftriaxona 2gr ev día 4/7
4. Azitromicina 500mg vo día 4/5
5. Paracetamol 1gr vo c8h sos
6. B ipratropio 2 puff c6h SOS
7. Rescatar resultado HC
8. Rescatar resultado TC TX
9. Derivo HODOM

andres david velasquez guerra
MEDICO TRATANTE
27124399-5

JEFE SERVICIO